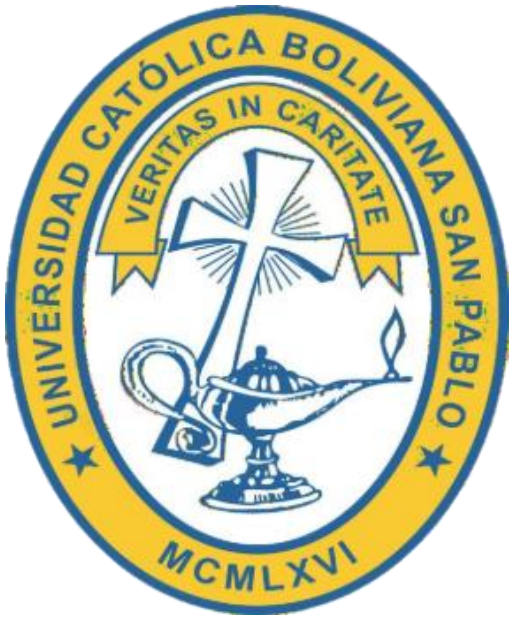
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"



Minuta de Entrevista y Relevamiento de Requerimientos

Proyecto: Sistema Web de Gestión Administrativa y de Investigación - Fundación Encuentro

Materia: Ingeniería de Software SIS-213

Estudiantes: (GRUPO 7)

Andrea Carolina Narváez Ortega

Jorge Manuel Calizaya Tito

Adriana Galilea Pando Mamani

Semestre: 2 - 2026

Docente: Ing. Miguel Angel Pacheco Arteaga

La Paz - Bolivia

ÍNDICE GENERAL

1. ENCABEZADO DEL ACTA 3
2. ANÁLISIS AS-IS 3
   2.1 RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3
   2.2 HERRAMIENTAS Y PROCESO ACTUAL 4
   2.3 PROBLEMAS IDENTIFICADOS 4
3. TRANSCRIPCIÓN DEL DIÁLOGO 5
   3.1 COMPRENSIÓN GENERAL DEL NEGOCIO 5
   3.2 EXPECTATIVAS SOBRE EL NUEVO SISTEMA 6
   3.3 USUARIOS, ROLES Y PERMISOS 7
   3.4 DATOS E INTEGRACIONES 7
   3.5 ASPECTOS DE CALIDAD Y DESEMPEÑO MENCIONADOS 8
   3.6 PREGUNTAS POR STAKEHOLDER 8
   3.7 CIERRE DE LA ENTREVISTA 9
4. CATÁLOGO PRELIMINAR DE NECESIDADES 10

1. ENCABEZADO DEL ACTA

El presente documento recoge el acta ENT-001, correspondiente a la entrevista sostenida con Kathia Morales, coordinadora y directora de Fundación Encuentro, el 18/09/2026. A continuación se detallan los datos formales del acta y, en las secciones siguientes, el análisis de la situación actual del negocio, la transcripción del diálogo y el catálogo preliminar de necesidades levantado a partir de ella.

Pregunta	Respuesta / hallazgo
Código del acta	ENT-001
Proyecto	Fundación Encuentro
Fecha / hora	18/09/2026 *(inicio 4:00 PM)*
Duración	● Inicio: 4:00 PM. ● Cierre: 5:30 PM.
Asistentes - persona entrevistada	Kathia Morales *(coordinadora y directora)*.
Asistentes - entrevistadores	Jorge Calizaya y Adriana Pando.

2. ANÁLISIS AS-IS

2.1 RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Fundación Encuentro es un centro de atención terapéutica cuyos pacientes llegan por llamada telefónica luego de conocer el centro en Facebook, TikTok, Instagram o por contactos personales. Toda la gestión del centro *(el registro del paciente, el registro de la consulta y el registro de los pagos)* se realiza de forma manual, apoyada en carpetas físicas, tarjetas, un cuaderno de verificación y un Excel antiguo que no ha sido digitalizado por completo. No existe ningún proceso automatizado.

Esta forma de trabajo genera varios problemas concretos: acumulación de carpetas físicas que después deben digitalizarse y subirse a la nube *(el principal cuello de botella detectado)*, falta de trazabilidad del historial de cada paciente, información duplicada entre los registros de pacientes antiguos, y pérdida de información como el error más frecuente reportado por la directora. La única forma de verificar que un dato sea correcto es revisándolo en el cuaderno, lo que vuelve lento cualquier control.

2.2 HERRAMIENTAS Y PROCESO ACTUAL

La siguiente tabla detalla, pregunta por pregunta, cómo describió la entrevistada las herramientas y la forma de trabajo vigentes en el centro:

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Qué herramientas utilizan actualmente?	● Excel antiguo, aún sin digitalizar por completo. ● Carpetas físicas de pacientes, tarjetas y una base de datos parcial. ● Un cuaderno para verificar información.

Pregunta	Respuesta / hallazgo
	● Datos que se registran del paciente: nombre, edad, fecha de ingreso, estado de la terapia *(iniciada, en desarrollo o concluida)*, diagnóstico de ingreso e hipótesis relacional. ● Facebook, TikTok e Instagram para captación.
¿Qué actividades son manuales y cuáles están automatizadas?	Todo es manual: registro de pagos, registro del paciente y registro de la consulta. No hay actividades automatizadas.
¿Dónde suelen producirse retrasos o cuellos de botella?	En la acumulación de carpetas y en el trabajo de digitalizarlas y subirlas a la nube.
¿Qué errores ocurren con mayor frecuencia?	Pérdida de información.
¿Existe información duplicada o difícil de rastrear?	Sí, en el registro de pacientes antiguos.
¿Se pierde, modifica o dificulta consultar información?	Sí, porque todo es manual y está archivado en carpetas.
¿Cuánto tiempo toma realizar las actividades principales?	Consulta de 45 minutos a una hora; terapia de 16 sesiones.
¿Cómo se verifica que la información sea correcta?	Con un cuaderno.

2.3 PROBLEMAS IDENTIFICADOS

A partir de lo anterior, la entrevistada identificó de forma directa cuál es el problema central del negocio y qué tareas le gustaría mejorar en primer lugar:

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Cuál es el principal problema del proceso actual?	La organización de la información es inexistente; se maneja manualmente con tarjetas y carpetas.
¿Qué tarea es más repetitiva o consume más tiempo?	El registro de los pacientes y de su historial.
¿Qué información le gustaría consultar inmediatamente y hoy es difícil obtener?	El historial del paciente.
Si pudiera mejorar tres pasos del proceso, ¿cuáles serían?	● Digitalizar el marketing. ● Contar con una base de datos. ● Digitalizar el registro administrativo.

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Qué consecuencias generan los errores o retrasos actuales?	La información queda desorganizada y, en el peor de los casos, se pierde.

El problema de fondo no es la falta de datos, sino la falta de un sistema que los organice y evite que se pierdan: la organización de la información es prácticamente inexistente, se maneja con tarjetas y carpetas, y el registro de pacientes y su historial es, según la propia directora, la tarea más repetitiva y la que más tiempo consume del centro.

3. TRANSCRIPCIÓN DEL DIÁLOGO

A continuación se transcribe el diálogo sostenido con Kathia Morales, combinando preguntas abiertas *(sobre el funcionamiento general del negocio, sus problemas y sus expectativas)* y preguntas cerradas o de verificación puntual *(por ejemplo, sobre cantidades de usuarios, dispositivos o mecanismos de seguridad)*. El texto de las respuestas corresponde a lo dicho por la entrevistada durante la sesión. El contenido entre paréntesis señala información que no fue abordada en la entrevista, o bien una propuesta del analista pendiente de validación con la directora, claramente separada de lo que la entrevistada afirmó.

3.1 COMPRENSIÓN GENERAL DEL NEGOCIO

Esta parte de la entrevista buscó entender, en términos generales, cómo funciona el proceso de atención de principio a fin, quién participa en cada etapa y qué información se maneja. La directora describió un flujo de cuatro momentos *(contacto telefónico, evaluación del caso, sesiones de terapia y cierre del caso)* en el que intervienen, además de ella, dos terapeutas y un colaborador de apoyo ocasional, así como hasta tres instituciones externas que derivan pacientes.

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Cómo se realiza actualmente el proceso, desde que inicia una solicitud hasta que finaliza?	● Contacto: el paciente llama por teléfono; conoció la existencia del centro por Facebook, TikTok, Instagram o por contactos. ● Evaluación: explica la situación que lo trae y se agenda una cita para evaluar el caso; el centro puede atender o no. ● Sesiones: primera cita con entrevista individual o colectiva según el caso. La consulta dura de 45 minutos a una hora y la terapia completa es de 16 sesiones. Se elabora una ficha de diagnóstico y luego fichas de seguimiento, con tareas para el paciente. ● Cierre: el caso queda como iniciado, en proceso o concluido; se emiten informes y se registra el historial y los pagos.
¿Qué actividades realiza usted dentro de este proceso?	Contacto con los pacientes. Además, como coordinadora y directora, dirige el centro.
¿Quiénes intervienen en cada etapa y qué responsabilidad tiene cada uno?	● Kathia: coordinadora y directora. ● Alizon: proceso e intervención terapéutica, marketing y representación institucional. ● Dalila: intervención terapéutica, marketing y elaboración de material para redes. ● Javier: colabora de manera ocasional en el manejo de redes sociales del centro.

Pregunta	Respuesta / hallazgo
	● Administración de carpetas de pagos: función que sirve a los tres roles terapéuticos y de gestión. ● Instituciones que derivan casos: Aldeas SOS *(convenio probable)*, Universidad Central y juzgados.
¿Qué información necesita recibir para realizar su trabajo?	Historial del paciente.
¿Qué información genera o entrega al finalizar su actividad?	Historial del paciente y registro de pagos. Además, fichas, informe de intervención sistémica e informe al juez.

3.2 EXPECTATIVAS SOBRE EL NUEVO SISTEMA

Al preguntarle directamente qué debería resolver el nuevo sistema, la entrevistada fue clara: quiere una herramienta web, utilizable desde celular y computadora, y muy fácil de aprender, que en términos generales:

- Digitalice el historial del paciente y las fichas de inicio y seguimiento, con numeración correlativa y filtros.
- Clasifique los casos en social y privado, y registre los casos del juzgado.
- Genere informes de intervención sistémica y al juez a partir de datos reales del caso, y los exporte a Word y PDF, editables.
- Incluya un genograma en el espacio de cada paciente.
- Exporte la información a Atlas.ti para análisis cualitativo y ofrezca un dashboard web.
- Registre pagos por QR y transferencia *(sin facturación, NIT cerrado)*.
- Controle el acceso por códigos: administrador con acceso total y terapeutas por caso.

Profundizando con preguntas más específicas sobre qué debería permitir hacer el sistema, qué datos son obligatorios y qué documentos debe generar, se obtuvieron las siguientes respuestas:

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Qué debería permitir hacer el nuevo sistema?	● Registro de pacientes, incluido el registro previo. ● Exportación e importación de pacientes e información antigua. ● Base de datos con numeraciones correlativas, incluyendo casos del juzgado *(clínica o intervención del juzgado)*. ● Dashboard general, pagos por QR y transferencia, división de casos en social y privado.
¿Qué datos deben registrarse obligatoriamente?	● Nombre, número de carpeta y fecha de ingreso. ● Estado del caso: iniciado, en proceso o en conclusión. ● Comentarios clínicos. ● Ficha de diagnóstico y ficha de seguimiento. ● Tareas asignadas a los pacientes. ● Genograma, en el mismo espacio del paciente.

Pregunta	Respuesta / hallazgo
	● *(Notas previas del relevamiento)* También edad, diagnóstico de ingreso e hipótesis relacional.
¿Qué búsquedas, filtros o consultas necesita?	Filtros al consultar los datos, por tipo de caso y otros criterios.
¿Qué reportes, comprobantes o documentos necesita generar?	● Informes de intervención sistémica. ● Informe al juez. ● Los informes deben estar digitalizados y/o autogenerados con la información real del caso, no inventada. ● Dashboard general. ● No hay facturación *(NIT cerrado)*: límite del sistema en esta parte.
¿El sistema debe enviar notificaciones o alertas? ¿Cuándo?	No fue tratado en la entrevista. *(Propuesta del analista, pendiente de validar: como opcional, recordatorios de sesión y de tareas pendientes para el terapeuta.)*
¿Qué procesos necesitan aprobación o validación antes de continuar?	● Para casos derivados o por orden judicial, el almacenamiento requiere el consentimiento del paciente *(notas previas del relevamiento)*. ● *(Propuesta del analista, pendiente de validar: el informe al juez debe ser revisado y aprobado por el terapeuta responsable antes de exportarse.)*
¿Qué excepciones o casos especiales deben contemplarse?	● Casos del juzgado, con clínica o intervención judicial. ● Casos sociales y privados, con tratamiento distinto. ● Pacientes antiguos con registros duplicados o incompletos. ● Entrevista individual o colectiva; cada proceso es diferente.

3.3 USUARIOS, ROLES Y PERMISOS

Se indagó también sobre quiénes usarían el sistema y qué debería poder ver o hacer cada uno, dado que el historial del paciente se considera información confidencial:

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Qué tipos de usuarios utilizarán el sistema?	● Administrador *(dirección)*. ● Terapeutas: dos, cada uno con su código. ● Dalila, con su propio código, y otro usuario con código. ● Usuario de marketing *(notas previas del relevamiento)*.
¿Qué puede hacer cada tipo de usuario?	● Administrador: acceso a todos los casos. ● Terapeutas y demás usuarios con código: ingresan y ven la información de los casos que les corresponden, gestionados por códigos y contraseñas por caso. ● Marketing: difusión y captación.
¿Hay información que algunos usuarios no deberían ver o modificar?	Sí: el historial del paciente es confidencial y se gestiona por códigos, de modo que cada usuario ve solo los casos asignados.

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Qué operaciones requieren aprobación de un responsable?	No fue tratado en la entrevista. *(Propuesta del analista, pendiente de validar: emisión del informe al juez, eliminación de un caso y cambios en casos concluidos, aprobados por el administrador.)*

3.4 DATOS E INTEGRACIONES

Respecto a los datos que el sistema debería almacenar y a su relación con herramientas externas, la entrevistada mencionó en particular la necesidad de trabajar en conjunto con Atlas.ti y con almacenamiento en la nube:

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Qué datos deben almacenarse y durante cuánto tiempo?	Historial clínico, fichas, tareas, genograma, informes, casos del juzgado, pagos y clasificación social o privada. Se requiere almacenamiento en la nube. *(El tiempo de conservación no fue definido; se pidió no limitar los datos.)*
¿Existe una base de datos o sistema externo del que se deba obtener información?	El Excel antiguo, las carpetas de pacientes, las tarjetas y el cuaderno de verificación.
¿El sistema deberá comunicarse con otros sistemas o servicios?	● Atlas.ti: transformar y exportar la información de la base de datos. ● Almacenamiento en la nube. ● No se pidió integración con facturación.
¿Qué información debe importar o exportar?	● Importar: pacientes e información antigua *(Excel y carpetas)*. ● Exportar: historial clínico y fichas a PDF y Word, con datos editables. ● Exportar: base de datos hacia Atlas.ti.

3.5 ASPECTOS DE CALIDAD Y DESEMPEÑO MENCIONADOS

Aunque no se trataron en profundidad, durante la conversación surgieron algunas menciones espontáneas sobre cuántas personas usarían el sistema a la vez, qué tan sencillo debe ser de aprender y qué tan segura debe ser la información:

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Cuántos usuarios podrían utilizar el sistema simultáneamente?	Un administrador con acceso a todos los casos, 2 terapeutas con 2 códigos, un código para Dalila y un código para otro usuario *(aproximadamente 4 a 5 usuarios en total)*.
¿Qué información se considera confidencial o sensible?	El historial del paciente.
¿Qué mecanismos de seguridad consideran necesarios?	Seguridad informática y acceso mediante códigos y contraseñas por caso.
¿Desde qué dispositivos se espera utilizar el sistema?	Celular y computadora.

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Qué tan sencillo debería ser aprender a utilizarlo?	Bastante sencillo.

3.6 PREGUNTAS POR STAKEHOLDER

Además de la conversación general con la directora, se adaptaron los perfiles genéricos de la guía de entrevista a los distintos roles presentes en Fundación Encuentro, para relevar la perspectiva particular de cada uno frente al sistema.

Dirección / Marketing

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Cómo se registran actualmente las consultas de nuevos pacientes?	Por llamada telefónica; el paciente llegó por Facebook, TikTok, Instagram o contactos. Se agenda una cita de evaluación.
¿Cómo se realiza el seguimiento de pacientes?	Con fichas de seguimiento en carpetas, tareas asignadas y un cuaderno.
¿Qué problemas existen con captación y seguimiento?	El marketing no está digitalizado, lo que lo convierte en uno de los tres pasos a mejorar.

Responsable financiero / Administración de pagos

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Qué información necesita para registrar o controlar las operaciones?	Registro de pagos por sesión, por QR o transferencia *(también efectivo)*, con división entre caso social y privado.
¿Qué documentos o comprobantes deben generarse?	No hay facturación *(NIT cerrado)*. Los documentos a generar aún están por definir.
¿Qué información debe ser trazable?	Registro de pagos por paciente y por caso.

Terapeutas

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Cómo se planifican y controlan actualmente las operaciones?	Sesiones de 45 minutos a una hora, en terapias de 16 sesiones, controladas con fichas y carpetas.
¿Qué recursos, estados o actividades deben monitorearse?	Estado del caso *(iniciado, en proceso, en conclusión)*, tareas asignadas y comentarios clínicos.
¿Dónde se producen retrasos o conflictos?	En la acumulación y digitalización de carpetas.

Paciente

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Qué necesita realizar con el sistema?	Los pacientes no usan el sistema; lo usa el personal.
¿Qué información espera recibir después de una solicitud?	Respuesta a su llamada y cita de evaluación.
¿Qué características harían que el sistema sea fácil de utilizar?	Que sea muy sencillo de aprender.

3.7 CIERRE DE LA ENTREVISTA

Para cerrar la sesión se preguntó a la entrevistada por temas pendientes, documentación disponible para revisión y posibles restricciones del proyecto:

Pregunta	Respuesta / hallazgo
¿Hay algún problema importante que no le haya preguntado?	No se registró respuesta.
¿Existe algún proceso que debamos observar directamente?	No fue tratado en la entrevista. *(Propuesta del analista, pendiente de validar: el registro de un paciente nuevo, el llenado de fichas y la elaboración de un informe al juez.)*
¿Hay documentos, formularios, reportes o archivos que podamos revisar?	Excel antiguo, carpetas y tarjetas de pacientes, fichas de inicio y de seguimiento, informes de intervención y al juez, y el cuaderno de verificación.
¿Existe alguna restricción legal, institucional, técnica o presupuestaria?	● Sin facturación *(NIT cerrado)*. ● Sin impuestos ni gestión de procesos judiciales. ● Confidencialidad del historial y consentimiento del paciente en casos derivados. ● Solo versión web.

4. CATÁLOGO PRELIMINAR DE NECESIDADES

A partir de lo transcrito en la sección anterior *(tanto de las respuestas directas de la entrevista ENT-001 como de notas previas del relevamiento con el centro)* se construyó el siguiente catálogo preliminar de necesidades. Cada necesidad conserva la fuente de la que proviene, de modo que pueda verificarse contra el diálogo transcrito.

ID	Necesidad	Fuente
N-01	Base de datos digital del historial de pacientes, con carpeta ordenada.	Entrevista ENT-001
N-02	Numeración correlativa continua, incluyendo casos del juzgado.	Entrevista ENT-001

ID	Necesidad	Fuente
N-03	Digitalizar y subir a la nube el Excel antiguo, las carpetas y las tarjetas.	Entrevista ENT-001
N-04	Filtros al consultar datos, por tipo de caso y otros criterios.	Entrevista ENT-001
N-05	Ficha de diagnóstico y ficha de seguimiento digitales, con tareas.	Entrevista ENT-001
N-06	Genograma en el espacio de cada paciente.	Entrevista ENT-001
N-07	Informes de intervención sistémica y al juez autogenerados con datos reales.	Entrevista ENT-001
N-08	Exportar historial y fichas a PDF y Word, editables.	Entrevista ENT-001
N-09	Categorización y análisis cualitativo con perspectiva de investigación.	Entrevista ENT-001
N-10	Exportar la base de datos a Atlas.ti para sistematización cualitativa.	Entrevista ENT-001
N-11	Dashboard general en la web.	Entrevista ENT-001
N-12	Registro de pagos por QR y transferencia *(y efectivo)*.	Entrevista ENT-001
N-13	Clasificar casos en social y privado.	Entrevista ENT-001
N-14	Acceso por códigos: administrador total y terapeutas por caso.	Entrevista ENT-001
N-15	Seguridad informática y confidencialidad del historial.	Entrevista ENT-001
N-16	Versión web para celular y computadora.	Entrevista ENT-001
N-17	Uso muy sencillo, de fácil aprendizaje.	Entrevista ENT-001
N-18	Digitalizar el marketing.	Entrevista ENT-001
N-19	Control contable: gastos mensuales y distribución de ingresos.	Notas previas del relevamiento
N-20	Foro público de investigaciones.	Notas previas del relevamiento
N-21	Planificación de personal.	Notas previas del relevamiento
N-22	Consentimiento del paciente en casos derivados o judiciales.	Entrevista ENT-001 / notas previas